Prévention et prise en charge de la syphilis chez la femme enceinte et en périnatalité

Recommandations SPILF-CNGOF

Jeu de diapositives réalisé par le comité des référentiels de la SPILF le 12 novembre 2025

Risques d'une syphilis pendant la grossesse

→ **Pour la mère** :

Ne modifie pas l'incidence, la sémiologie, l'histoire naturelle et la gravité de la maladie

Transmission :

- par voie transplacentaire hématogène in utero
- ou par contact cutanéo-muqueux en per partum

Pas de transmission par le lait

Risques d'une syphilis pendant la grossesse

→ **Pour le fœtus/nouveau-né** :

Le risque de transmission est fonction :

- de l'âge gestationnel

la transmission débute à 16 SA et augmente avec l'âge gestationnel

- du stade de la syphilis maternelle

risque estimé à 60-100% en cas de syphilis primaire ou secondaire

à 40% en phase latente précoce

à 10% en phase tardive

Conséquences :

- perte fœtale (40%)
- prématurité (25%)
  - poids de naissance < 2500 g (33%)
  - syphilis congénitale (SC) précoce (début avant l'âge de 2 ans) ou tardive (au-delà)

Mesures de prévention de la syphilis congénitale

→ Informer les femmes avant et pendant leur grossesse sur les modes de transmission des IST et sur leur prévention

→ Proposer un dépistage de la syphilis aux femmes en âge de procréer avec facteur de risque d'IST

- en consultation pré-conceptionnelle
- ET au minimum une fois par an en cas de facteur de risque persistant
- ET après chaque rapport sexuel à risque

→ Dépister la syphilis pendant chaque grossesse, au mieux avant 10 SA

Répéter le dépistage de la syphilis pendant la grossesse en cas de changement de partenaire(s) et/ou de rapport sexuel à risque

Informer la patiente de l'importance du dépistage de

Caractéristiques cliniques de la syphilis chez l'adulte et en post-natal

Classement	Stade	Manifestations cliniques	Délai d'apparition	Durée habituelle	Evolution
Précoce (Evolution < 1 an)	**Primaire**	Chancre: typiquement unique, bien limité, indolore Constant mais peut passer inaperçu Adénopathies satellites Neurosyphilis*	10 à 90 jours après la contamination (médiane de 21 jours)	2 à 6 semaines	Résolution possible même sans traitement En l'absence de traitement, évolution vers une syphilis secondaire dans 25% des cas
	Secondaire	Dissémination systémique pléiomorphe Eruption cutanée maculo-papuleuse : roséole, … Ulcération(s) muqueuse(s) Adénopathie(s) Lésion(s) condylomateuse(s) Hépatite Néphrite Lésion(s) ophtalmologique(s) : uvéite, … Neurosyphilis* Fièvre	Habituellement 2 à 12 semaines après l'apparition du chancre (possible jusqu'à 6 mois)	3 à 12 semaines	Résolution possible même sans traitement En l'absence de traitement, évolution vers une syphilis tertiaire dans 30% des cas
	Latente précoce **Latente tardive**	Asymptomatique			En l'absence de traitement, évolution vers une syphilis tertiaire dans 30% des cas
Tardive (Evolution > 1 an ou inconnue)	**Tertiaire**	Cardio-vasculaire : aortite Neurologique : - Paralysie générale - *Tabes dorsalis* : dégénérescence des cordons postérieurs de la moelle spinale	10 à 30 ans 5 à 7 ans 10 à 20 ans		En l'absence de traitement, décès possible

Diagnostic microbiologique d'une syphilis maternelle

→ Repose sur la **sérologie syphilis**

Tests tréponémiques (TT) : TPHA, EIA, CMIA/CLIA, Immunoblot et Western Blot
Tests non tréponémiques (TNT) : VDRL, RPR

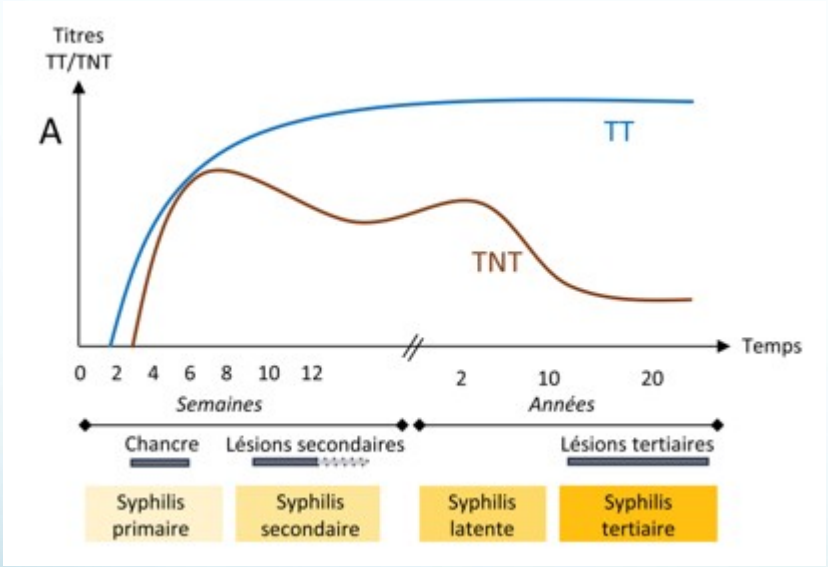
La prescription doit mentionner les **renseignements cliniques** qui vont conditionner les tests réalisés :

- patient symptomatique et/ou femme enceinte : TT et TNT d'emblée
- patient asymptomatique : TT, le TNT ne sera réalisé qu'en cas de positivité du TT

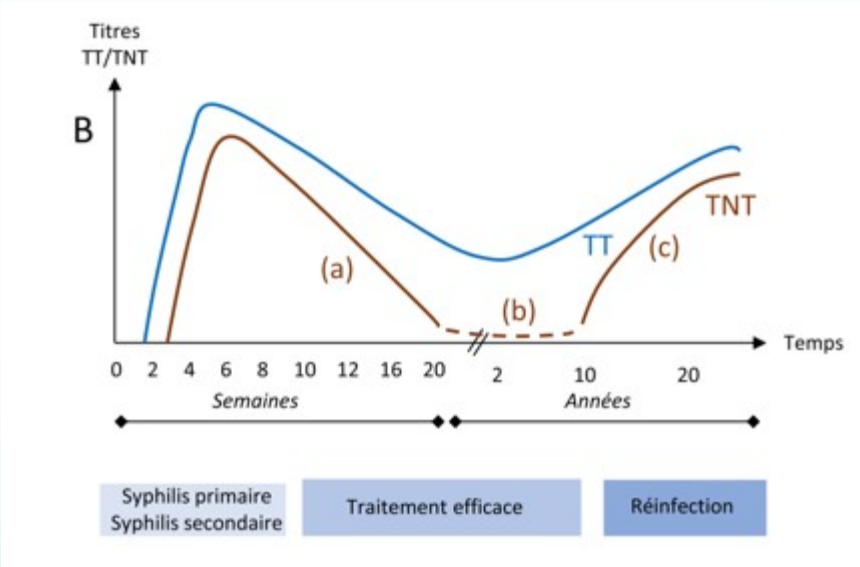
Diagnostic microbiologique d'une syphilis maternelle

Evolution des marqueurs sérologiques

A- En l'absence de traitement, en cas de traitement inadapté ou de tréponématose non syphilitique



B- Si traitement efficace et si réinfection :

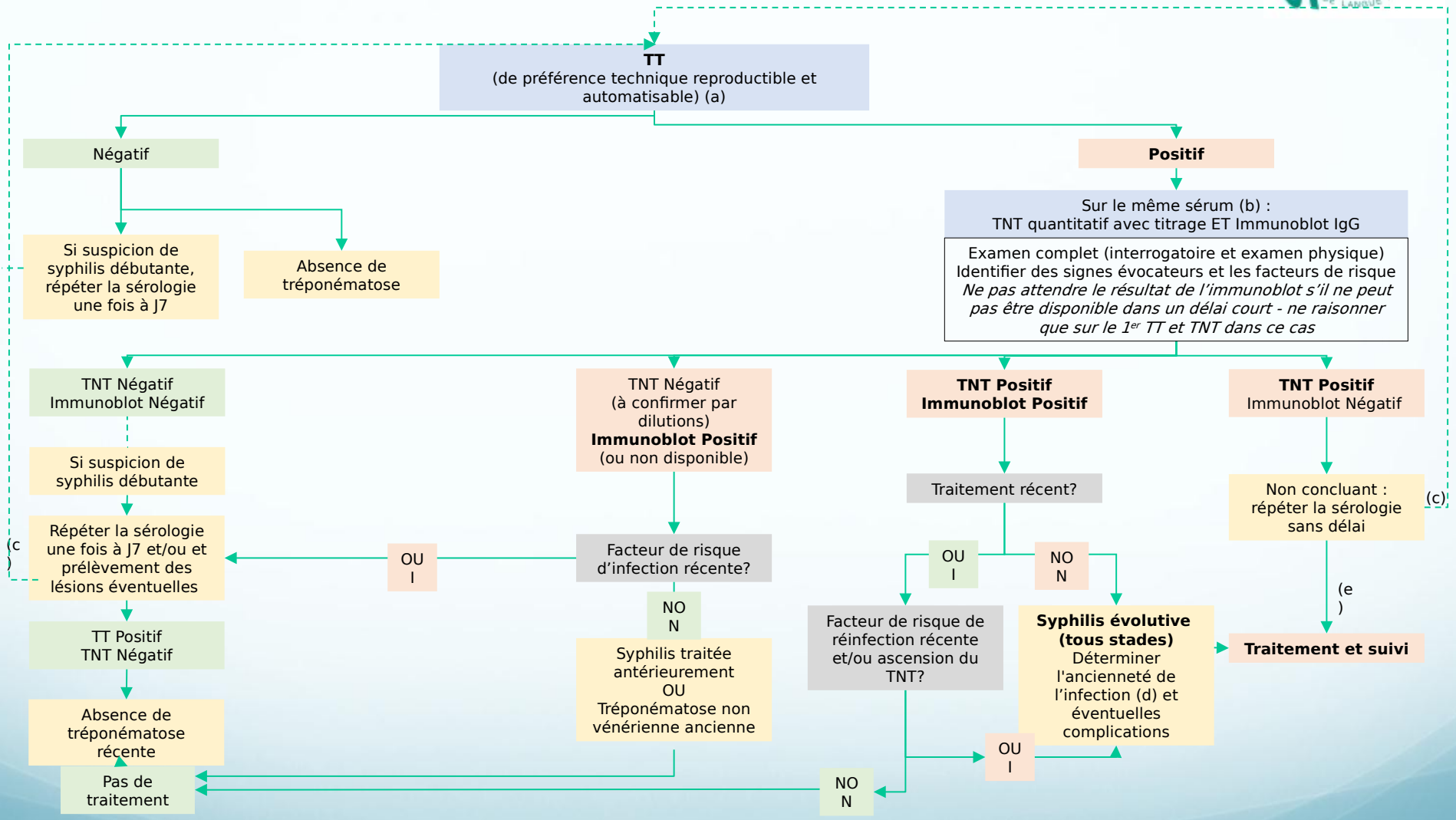


(a) Après traitement efficace, le TNT est divisé par 4 (2 dilutions) après 3 mois de traitement.
Ce délai peut être allongé dans le traitement d'une syphilis tardive et en cas de co-infection VIH non contrôlée

(b) Certains patients correctement traités gardent un TNT faiblement positif en particulier si le traitement est instauré tardivement

(c) En cas de réinfection, le TNT est multiplié par au moins 4

Algorithme d'interprétation



(a) Préciser le contexte de la grossesse sur la prescription afin que le laboratoire effectue un test de confirmation (immunoblot)
(b) Ces examens sont en général effectués à l'initiative du biologiste
(c) Les sérologies de contrôle doivent se faire de préférence dans le même laboratoire
(d) La détermination de l'ancienneté de l'infection repose sur l'examen physique et l'interrogatoire : notion de syphilis antérieure chez la patiente ou chez son(sa) partenaire, de sérologies antérieures positives ou d'une séroconversion documentée, de syphilis traitée
(e) Dans le doute, initier le traitement.
TT : test tréponémique, TNT : test non tréponémique.

Prise en charge maternelle et obstétricale

1. Examen clinique complet + bilan d'IST

4 questions :
- Quel est le stade de la syphilis ?
- Y-a-t-il des signes évocateurs de neurosyphilis ?
- Y-a-t-il une IST associée ?
- La patiente est-elle allergique aux bêtalactamines ?

Prise en charge maternelle et obstétricale

2. Traitement :

- Syphilis précoce : 2 doses de benzathine pénicilline (BGP) 2,4 MUI IM à 1 semaine d'intervalle
- Syphilis tardive : 3 doses de BPG 2,4 MUI IM à 1 semaine d'intervalle
- Neurosyphilis : benzylpénicilline 20 MUI/jour IV pendant 14 jours

→ **Le traitement doit être institué le plus précocement possible, idéalement complet avant 16 SA**

Si intervalle > 9 j entre 2 doses pour syphilis précoce, tardive ou non datée ou si interruption > 24h pour une neurosyphilis : recommencer complètement le traitement

- *Prévention systématique de la réaction de Jarisch-Herxheimer :*

- Paracétamol PO 1 g 2 h avant l'injection de BPG, puis 1 g/8 h pendant 72 h
- Alternative ou si fièvre > 38°C > 2 h : prednisone 0,3 à 0,5 mg/kg/jour PO 48h

Prise en charge maternelle et obstétricale

En cas d'allergie aux bêtalactamines

Réaction mineure isolée (ex : vomissements, diarrhée, céphalées, mycoses…) Histoire familiale d'allergie aux bêtalactamines Réaction de JH lors d'une injection précédente	Exanthème maculo-papuleux bénin Survenue > 6 h après la prise d'ATB ET durée < 7 j ET sans urticaire ET impliquant < 50% de la surface corporelle ET sans de réaction systémique ET sans traitement systémique hormis des antihistaminiques	Réaction restant inclassable d'après l'anamnèse ET n'ayant pas requis de traitement ou de surveillance médicale particulière	Réaction immédiate mais non grave Exanthème maculo-papuleux modéré > 7 j + Traitement corticoïde local OU Exanthème maculo-papuleux systémique > 50% de la surface corporelle sans réaction systémique OU Urticaire différée > 1 h après exposition OU Exanthème maculo-papuleux modéré mais comorbidités graves	Anaphylaxie (symptômes respiratoires et/ou vasculaires, angiœdème) < 1 h après exposition au médicament OU Urticaire < 1 h après exposition au médicament OU Tests cutanés positifs OU Hypersensibilité fréquente aux médicaments OU Hypersensibilité immédiate sévère	Réaction grave différée (syndrome de Lyell, syndrome de Stevens Johnson, pustulose exanthématique aigüe généralisée, syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse, DRESS, cytopénies, hépatite, néphrite interstitielle, purpura, vascularite) OU Exanthème maculo-papuleux sévère impliquant > 50% de la surface corporelle et signes de gravité OU Réaction cutanée grave
Risque équivalent à la population générale	**Risque faible**	**Risque faible à intermédiaire**	**Risque intermédiaire**	**Risque élevé de réaction grave immédiate**	**Risque élevé de réaction grave retardée**
BPG	- Informer du risque de réaction allergique - Tests cutanés optionnels - BPG	- BGP avec induction de tolérance en hospitalisation, sous surveillance médicale, avant chaque injection - OU Ceftriaxone 1g/ j IM ou IV pendant 14 jours, avec surveillance hospitalière les 2 premiers jours		- Tests cutanés - Si tests cutanés non réalisables dans un délai court, concertation entre allergologue/ obstétricien/pédiatre	Tous les médicaments de la même classe sont interdits - Doxycycline à 100 mg x2/j pendant 14 j (syphilis précoce) ou 21 j (syphilis tardive)

IM : intramusculaire; IV : intraveineux; BGP : benzathine pénicilline G; JH : Jarisch-Herxeihmer (réaction de); DRESS : drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms

Protocole d'induction de tolérance disponible sur : https://www.cnr-ist.fr/documents-de-reference-2.html

Prise en charge maternelle et obstétricale

3. Suivi :

- ***Consultation à 1 mois*** *:*

- Vérification de la réalisation du traitement et du dépistage des autres IST
- Evaluer le risque de réinfection : dépistage et du traitement des partenaires

- ***Suivi efficacité thérapeutique :***

- TNT à M2 puis mensuel jusqu'à l'accouchement dont à M3, M6 et M12 de la fin du traitement (+ M24 si syphilis tardive ou datation impossible)
- ET TNT dans tous les cas à l'accouchement (pour dosage comparatif avec TNT du NN)
- Toutes les sérologies doivent si possible être effectuées dans le même laboratoire
- Si ré-ascension du TNT : échec du traitement ou réinfection => avis spécialisé

Prise en charge maternelle et obstétricale

3. Suivi :

- ***Si syphilis non complètement traitée avant 16 SA :***

- Evaluation fœtale initiale par échographie
- Avis CPDPN si possible : surveillance fœtale par échographie à la recherche de signes de SC et discussion d'une amniocentèse si anomalies échographiques

- **Allaitement maternel non contre-indiqué**
  sauf si chancre mammaire ou roséole (avis spécialisé)

échographiques en faveur d'une infection fœtale/syphilis congénitale

Signes échographiques	Signes de SC précoce	Signes de SC tardive
Signes fœtaux - Retard de croissance intra utérine - Hépatomégalie - Splénomégalie - Hyperéchogénicité intestinale - Epanchements des séreuses - Anémie (augmentation de débit dans l'artère cérébrale moyenne) - Microcéphalie - Œdème sous-cutané **Signes annexiels** - Oligo/hydramnios - Placentomégalie	- Rhinorrhée (« snuffles ») - Signes cutanés : pétéchies, rhagades, lésions planes ou bulleuses prédominant aux paumes et plantes - Atteintes viscérales : hépatique, rénale, pulmonaire, adénopathies - Troubles neurosensoriels - Atteinte ostéoarticulaire Souvent non visibles à la naissance - apparition le plus souvent dans les 4 premières semaines de vie	- Déformations crânio-faciales - Atteintes ostéoarticulaires - Anomalies des dents définitives - Troubles neurosensoriels - Hémoglobinurie paroxystique au froid Triade de Hutchinson : anomalies dentaires + surdité + kératite interstitielle

SC : syphilis congénitale

Prise en charge en salle de naissance

Pour les patientes avec diagnostic de syphilis pendant la grossesse		
	Informations permettant d'évaluer le niveau de risque de SC renseignées dans le dossier obstétrical: Date de la fin du traitement maternel • Antibiotique administré • Stade de l'infection maternelle • Evolution du TNT si disponible	**Risque élevé** Syphilis maternelle précoce (< 1 an) après 16 SA OU titre de TNT maternel initial > 8 après 16 SA OU traitement maternel non reçu ou incomplet OU traitement maternel sans pénicilline G OU traitement maternel initié après 28 SA OU traitement maternel complété moins d'1 mois avant l'accouchement OU pas de décroissance du TNT maternel d'un facteur 4 après 2-3 mois de traitement (si ≥ 4 au diagnostic) **Risque nul** Syphilis maternelle traitée de manière adéquate < 16 SA, avec décroissance sérologique, et absence d'argument pour une réinfection **Risque intermédiaire** Autres cas
	Respect des précautions standards et des règles d'asepsie pendant l'accouchement et la prise en charge du NN	Précautions de type contact si contact avec muqueuses ou lésions cutanées contagieuses
	Examen clinique du NN	Recherche de signes de SC, respect des précautions complémentaires contact Prélèvement éventuel pour PCR de toute lésion ou écoulement nasal
	Prélèvement sérum mère et enfant (sang périphérique)	Comparaison des titres de TNT enfant/mère Dosage IgM anti-tréponème enfant si disponible (Prélèvements à analyser dans le même laboratoire)
Pour les patientes avec risque élevé ou intermédiaire de syphilis congénitale pour leur enfant		
	Prélever fragment placenta pour PCR et IHC si disponible dans le centre de prise en charge	

SC : syphilis congénitale; IHC : immunohistochimie; TNT : test non tréponémique; NN : nouveau-né

de la syphilis post-natale

AVANT la naissance

RISQUE ELEVE DE SC	RISQUE NUL DE SC	RISQUE INTEMEDIAIRE DE SC
AU MOINS 1 item parmi : Syphilis maternelle précoce (primaire ou < 1 an) après 16 SA TNT maternel initial > 8 après 16 SA Traitement maternel non reçu ou incomplet Traitement maternel sans pénicilline G Traitement maternel initié après 28 SA Traitement maternel complété < 1 mois avant l'accouchement Absence de décroissance du TNT maternel d'un facteur 4 après 2-3 mois de traitement (si ≥ 4 au diagnostic)	TT négatif pendant toute la grossesse OU traitement maternel par BPG complet < 16 SA ET absence d'argument en faveur d'une réinfection maternelle ET aucun critère de risque élevé	Autres cas

Examen clinique + TT + TNT + IgM par immunoblot (sérum nouveau-né) le plus tôt après la naissance + **Sérologie maternelle** dans le même laboratoire +/- PCR placenta/prélèvement fœtus/enfant

APRÈS la naissance

Signes cliniques de SC ET syphilis maternelle pendant la grossesse
OU TNT NN/TNT maternel > 4

OU PCR T. *pallidum* positive sur placenta ou tout prélèvement du fœtus/enfant

OU IHC positive sur placenta

OU IgM NN positives

OUI

NON ou en attente

Syphilis confirmée ou probable

Traitement : Pénicilline G IV 10 jours (14 j si neurosyphilis)
À débuter le plus précocement possible, et < 7 j suivant le diagnostic

- NN ≤ 7 jours : 50 000 UI/kg/12h jusqu'à J7 puis 50 000 UI/kg/8h
- NN > 7 jours : 50 000 UI/kg/8h

(pas de prévention systématique de la réaction de JH mais surveillance clinique)

Si interruption de traitement > 24h : recommencer un traitement complet

NN à risque nul de SC → TNT NN négatif IgM et PCR et IHC neg si faites → **SC exclue** Pas de traitement Pas de surveillance

NN à risque intermédiaire de SC → **SC peu proba** Pas de traitement Surveillance clinique et sérologique jusqu'à négativation du TNT puis TT à 18 mois

NN à risque élevé de SC → **SC possible**

Bilan complémentaire recommandé
NFS
Bilan hépatique Ionogramme sanguin créatininémie
Bandelette urinaire (protéinurie)
LCS (cytologie, protéinorachie, synthèse intrathécale VDRL)
Radiographie des os longs
Examen ophtalmologique complet (lampe à fente et fond d'oeil)
Potentiels évoqués auditifs et échographie transfontanellaire

Traitement : BPG
Dose unique 50 000 UI/kg IM

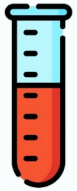
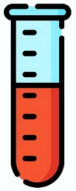
(pas de prévention systématique de la réaction de JH mais surveillance clinique)

Suivi
Sérologique (TT et TNT) tous les 3 mois (si TNT NN positif à la naissance) et jusqu'à négativation du TNT puis TT à 18 mois
Clinique : dépister les séquelles cliniques et neurodéveloppementales et inclusion dans réseau "enfant vulnérable"

BGP : benzathine pénicilline G; SC : syphilis congénitale; M : mois; JH : Jarisch-Herxeihmer (réaction de); IHC : immunohistochimie; TNT : test non tréponémique; IM : intramusculaire; VDRL : Veneral Disease Research Laboratory; NN : nouveau-né

Points clés

Syphilis chez la femme enceinte et en périnatalité



EN PRÉ-CONCEPTIONNEL

Sérologie (TT)
- En cas de FDR au moins 1 fois/an
- ET après chaque rapport à risque (dès que possible ET 6 semaines plus tard)

PENDANT LA GROSSESSE

Sérologie (TT)
- A la 1ère visite prénatale **idéalement avant 10 SA**
- A répéter pendant la grossesse et à l'accouchement **si FDR d'IST**

SYPHILIS MATERNELLE

Traitement URGENT
quel que soit le stade de l'infection
Idéalement AVANT 16 SA
Benzathine pénicilline 2,4 MUI IM
- Précoce (< 1 an) : 2 doses à une semaine d'intervalle
- Tardive ou non datée : 3 doses à une semaine d'intervalle

Bilan IST
Dépistage traitement partenaires
Surveillance foetale

POUR L'ENFANT : SYPHILIS CONGÉNITALE ?

Évaluer le risque avant la naissance
+
Prélever avant J3
(TT + TNT + IgM) du NN
+
Syphilis confirmée ou probable : Benzathine pénicilline 50 000 UI/Kg/8h
Dès que possible
pendant 10 à 14 jours

Informer les femmes sur les modes de transmission et la prévention des IST

Respect des règles d'asepsie et précautions contact

- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41061819/
- Délai d'application : 5 ans

Quizz – vrai ou faux

- La transmission transplacentaire de la syphilis débute à 16 SA et augmente avec l'âge gestationnel ?
- Les tests tréponémiques et non tréponémiques doivent être réalisés d'emblée quelque soit la situation clinique ?
- Le traitement d'une syphilis précoce de la femme enceinte consiste en 1 injection de benzathine pénicilline 2,4 MU IM ?
- La prise en charge de la syphilis post-natale dépend de l'évaluation du risque de syphilis congénitale (risque élevé/nul/intermédiaire), de l'examen clinique du nouveau-né et du TT/TNT/IgM par immunoblot sur sérum du NN et sérologie maternelle ?
- La syphilis se transmet par le lait ?

Quizz – vrai ou faux

- La transmission transplacentaire de la syphilis débute à 16 SA et augmente avec l'âge gestationnel ? **VRAI**

- Les tests tréponémiques et non tréponémiques doivent être réalisés d'emblée quelque soit la situation clinique ? **FAUX -** Patient symptomatique et/ou femme enceinte : TT et TNT d'emblée. Patient asymptomatique : TT, le TNT ne sera réalisé qu'en cas de positivité du TT

- Le traitement d'une syphilis précoce de la femme enceinte consiste en 1 injection de benzathine pénicilline 2,4 MU IM ? **FAUX -** 2 doses de benzathine pénicilline 2,4 MUI IM à 1 semaine d'intervalle

- La prise en charge de la syphilis post-natale dépend de l'évaluation du risque de syphilis congénitale (risque élevé/nul/intermédiaire), de l'examen clinique du nouveau-né et du TT/TNT/IgM par immunoblot sur sérum du NN et sérologie maternelle ? **VRAI**